

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENELUSURAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) HILANG UNTUK PENGOBATAN ARV		
	No. Dokumen 351.16/I-SPO/HIV/VI/2026	No. Revisi 00	No. Halaman 1/13
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 20 Juni 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	1. Penelusuran ODHIV adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk memastikan setiap ODHIV yang hilang setelah diagnosis, ODHIV yang hilang setelah masuk perawatan, dan ODHIV yang hilang setelah pengobatan ARV mendapatkan intervensi penelusuran (pesan teks/telepon dan/atau kunjungan rumah) sehingga kembali mengakses layanan HIV untuk pengobatan ARV. Prinsip penelusuran ODHIV hilang adalah berpusat pada ODHIV, konfidensial, sukarela, serta mengutamakan keamanan petugas dan ODHIV. 2. Kriteria memenuhi syarat pasien ODHIV hilang yang ditelusuri merupakan: a. ODHIV yang sudah terdiagnosis tetapi belum memulai pengobatan ARV, yaitu: a) ODHIV hilang setelah diagnosis tetapi belum masuk dalam perawatan. b) ODHIV hilang setelah masuk perawatan tanpa kontraindikasi klinis tetapi belum memulai ARV. b. ODHIV <i>Loss to Follow Up</i> (LFU) setelah pengobatan ARV adalah ODHIV dalam pengobatan ARV yang tidak berkunjung untuk pengambilan ARV lebih dari 28 hari atau satu bulan sejak ditetapkan sebagai <i>Missed Appointment</i> (MA). 3. <i>Missed Appointment</i> (MA) atau alpa satu kali adalah ODHIV dalam pengobatan ARV yang tidak berkunjung untuk pengambilan ARV dalam rentang 28 hari atau satu bulan sejak jadwal kunjungan yang ditentukan. MA masih dihitung sebagai ODHIV sedang mendapatkan pengobatan ARV. 4. Penyisiran data adalah proses identifikasi dan konfirmasi status akhir ODHIV dalam layanan HIV, dengan menggunakan data individu yang tersedia di SIHA. 5. ODHIV hilang tidak potensial ditelusuri adalah ODHIV hilang tanpa informasi kontak, yaitu alamat dan nomor telepon. 6. ODHIV potensial ditelusuri adalah ODHIV hilang yang memiliki kelengkapan alamat dan/atau nomor telepon. 7. Kategori ODHIV potensial ditelusuri dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan durasi hilang sebagai urutan prioritas kegiatan penelusuran: a. 2 – 24 bulan ($\leq$ 2 tahun),		

	b. 25 – 60 bulan (> 2 – 5 tahun), c. > 60 bulan (> 5 tahun). 8. Petugas Penelusur adalah orang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau disepakati untuk berpartisipasi dalam melakukan penelusuran ODHIV hilang di layanan PDP.
Tujuan	Sebagai acuan teknis di layanan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penelusuran melalui penjelasan strategi penelusuran ODHIV hilang untuk pengobatan ARV.
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 895.2/I-PDM/HIV/X/2025 tentang Pedoman Pelayanan HIV/AIDS
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>, dan Infeksi Menular Seksual. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana HIV. 3. Panduan Praktis Penelusuran ODHIV Hilang Untuk Pengobatan ARV.
Prosedur / Langkah - langkah	1. Persiapan Alat dan Bahan : a. Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) 2.1 (Lampiran 1) a) Data dasar (<i>baseline</i>), menentukan titik awal periode penelusuran. b) Data pasien periode 12 bulan terakhir sesuai dengan periode data dasar. c) Data kunjungan periode 12 bulan terakhir sesuai dengan periode data dasar. d) Register ODHIV pernah hilang. b. Rekam Medis (Cetak/Elektronik). c. Ikhtisar keperawatan pengobatan ART (<i>opsional</i>). 2. Petugas yang melaksanakan : a. Tim layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP); b. Komunitas/LSM Lokal/Kader yang bermitra dengan layanan dan atau orang atau pihak lain yang ditunjuk untuk terlibat dalam penelusuran ODHIV hilang. 3. Langkah - langkah : a. Penyisiran Data (<i>Mopping Up</i>) a) Persiapan Validasi Data 1. Petugas Layanan menentukan data dasar (<i>baseline</i>) untuk dilakukan penyisiran. 2. Petugas RR memastikan data pasien dan data kunjungan terbaru telah diinput ke dalam aplikasi SIHA 2.1 sampai dengan periode penyisiran data ODHIV yang akan dilakukan. 3. Petugas Layanan menentukan titik awal dan data dasar yang akan digunakan dalam proses penyisiran data.

	Contoh : titik awal bulan Mei 2024, maka data yang digunakan adalah data kumulatif ODHIV sampai dengan Mei 2025. 4. Petugas RR menarik data ODHIV di SIHA 2.1 (data pasien dan data kunjungan sesuai dengan periode data dasar yang ditentukan). b) Validasi Data 1. Petugas RR memastikan tidak ada duplikasi pada data ODHIV. 2. Petugas RR melakukan verifikasi data individu dengan sumber informasi/dokumentasi lain. c) Petugas RR mengidentifikasi data ODHIV yang masuk ke dalam kategori tidak potensial ditelusuri atau potensial ditelusuri menggunakan data Register ODHIV Pernah Hilang. d) Melengkapi Data ODHIV Hilang yang Tidak Potensial Ditelusuri 1. Petugas RR upaya penyisiran lanjutan ke sumber data lain, seperti ikhtisar keperawatan/buku bantu/rekam medis atau sistem informasi lain seperti E-PUS/SIMPUS/SIMRS untuk mencari kontak ODHIV hilang yang tidak potensial ditelusuri. ■ Jika ditemukan informasi kontakannya maka ODHIV tersebut dimasukkan ke dalam kategori ODHIV hilang potensial ditelusuri. ■ Jika tidak ditemukan informasi kontakannya maka ODHIV tersebut berstatus ODHIV tidak aktif. e) Tindak lanjut Hasil Penyisiran ODHIV Hilang Hasil penyisiran data ODHIV hilang akan ditindaklanjuti sebagai berikut: 1. Petugas RR memberikan daftar ODHIV hilang potensial ditelusuri kepada petugas penelusur. 2. Petugas RR memberikan simbol khusus pada ODHIV tidak potensial ditelusuri yaitu dengan menambahkan simbol @ di belakang variable input Rekam Medis di SIHA. Contoh: nomor rekam medis awal 123456 menjadi 123456@ sebagai penanda bahwa pasien saat ini dinyatakan tidak aktif. b. Pertemuan Koordinasi Pertemuan koordinasi bertujuan memberikan ruang diskusi bagi tim penelusur untuk membuat strategi penelusuran ODHIV. Pertemuan ini dihadiri oleh PJ HIV, dokter, perawat, petugas RR, petugas pendamping, dan petugas penelusur. Adapun dinas kesehatan kabupaten/kota dapat terlibat sebagai pengawas. Pertemuan koordinasi ini dapat dilakukan setiap bulan atau triwulan. Tahapan pertemuan koordinasi adalah sebagai berikut: a) Persiapan Koordinasi Awal 1. Petugas RR menyiapkan data register ODHIV hilang dari SIHA 2.1 dalam rentang tanggal 6 sampai 10 pada bulan berjalan.
--	--

	- Petugas RR menginformasikan kepada PJ HIV jumlah ODHIV hilang potensial untuk ditelusuri. - Petugas pendamping memberikan daftar ODHIV dampingannya kepada fasyankes untuk kebutuhan sinkronisasi data dampingan dengan ODHIV yang terdaftar di fasyankes. - PJ HIV berkoordinasi dengan petugas penelusur terkait tanggal dan waktu pertemuan. Tanggal pertemuan sebaiknya dilakukan dalam rentang tanggal 6 sampai 15 di setiap bulan setelah data register ODHIV hilang disiapkan. - PJ HIV membuat undangan pertemuan koordinasi. (Lampiran 2) b) Pertemuan Koordinasi Awal - Tim layanan HIV memaparkan daftar ODHIV potensial ditelusuri. - Tim layanan HIV menentukan petugas penelusur. Petugas penelusur dapat berasal dari LSM pendamping atau tim layanan HIV atau Kader (jika dibutuhkan, terutama pada sasaran ibu hamil dengan HIV). - Fasyankes dapat mengeluarkan surat tugas/surat keterangan dan sejenisnya bagi petugas penelusur bila dibutuhkan (sesuai kebijakan setempat). (Lampiran 3) c) Persiapan Koordinasi Rutin - Petugas RR sudah menyiapkan data register ODHIV hilang dari SIHA 2.1 dalam rentang tanggal 6 sampai 10 berdasarkan hasil penyisiran dan penelusuran terakhir. - Petugas RR menginformasikan kepada PJ HIV jumlah ODHIV hilang potensial untuk ditelusuri. - Petugas pendamping memberikan daftar terkini terkait ODHIV dampingan kepada fasyankes untuk kebutuhan sinkronisasi data dampingan dengan ODHIV yang terdaftar di fasyankes. - PJ HIV berkoordinasi dengan petugas penelusur terkait tanggal dan waktu pertemuan. Tanggal pertemuan sebaiknya dilakukan dalam rentang tanggal 6 sampai 15 di setiap bulan setelah data register ODHIV hilang disiapkan. - PJ HIV membuat undangan pertemuan koordinasi. d) Pertemuan Koordinasi Rutin - Tim layanan HIV memaparkan hasil penelusuran bersumber dari menu penelusuran di SIHA 2.1. - Peserta pertemuan koordinasi kemudian dapat berdiskusi mengenai keberhasilan, kendala, dan strategi penelusuran berikutnya. - Tim layanan HIV menentukan petugas penelusur. Petugas penelusur dapat berasal dari LSM pendamping atau tim layanan HIV atau Kader (jika dibutuhkan, terutama pada sasaran ibu hamil dengan HIV) atau pihak lain yang ditunjuk atau disepakati.
--	---

	4. Penentuan rencana tindak lanjut dan tanggal pertemuan koordinasi berikutnya. c. Penelusuran a) Petugas RR menentukan kategori prioritas penelusuran berdasarkan lamanya ODHIV hilang dengan ketentuan: 1. ODHIV hilang 2-24 bulan (≤ 2) 2. ODHIV hilang 25-60 bulan ($> 2-5$ tahun) 3. ODHIV hilang > 60 bulan (> 5 tahun) b) Petugas RR membagi kategori ODHIV sebagai berikut: 1. Hilang setelah diagnosis 2. Hilang setelah masuk perawatan 3. Hilang setelah pengobatan ARV c) Petugas penelusur merencanakan cara melakukan penelusuran menggunakan daftar ODHIV hilang potensial ditelusuri. 1. ODHIV hilang setelah diagnosis a. Petugas penelusur menghubungi pasien melalui pesan teks atau telepon sebanyak 3 kali pada hari dan waktu yang berbeda selama 3 hari berturut-turut. b. Jika poin a tidak berhasil, maka petugas penelusur melakukan kunjungan rumah sebanyak 2 kali pada hari dan waktu yang berbeda. 2. ODHIV hilang setelah masuk perawatan dan hilang setelah pengobatan ARV. a. Petugas penelusur menghubungi pasien melalui pesan teks sebanyak 1 kali. b. Jika pesan teks tidak berhasil, petugas penelusur menghubungi melalui telepon sebanyak 3 kali pada hari dan waktu yang berbeda selama 3 hari berturut-turut. c. Jika panggilan telepon tidak berhasil, petugas penelusur dapat melakukan kunjungan rumah sebanyak 2 kali pada hari dan waktu yang berbeda. d) Bila berhasil dihubungi atau ditemui, petugas penelusur memastikan ODHIV hilang untuk segera berkunjung ke layanan HIV dalam rentang waktu satu minggu atau sesuai waktu yang disepakati bersama. e) Petugas penelusur melakukan penelusuran ODHIV hilang dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak daftar penelusuran diterima. f) Petugas penelusur mencatat hasil akhir penelusuran dan melaporkan hasil akhir penelusuran tersebut ke petugas layanan dalam waktu satu hari kerja setelah dilakukan penelusuran. d. Tindak Lanjut Hasil Akhir Penelusuran a) Petugas penelusur mencatat hasil penelusuran di formulir list penelusuran dan melaporkan semua
--	--

hasil penelusuran, baik yang ditemukan ataupun tidak ditemukan/tidak berhasil dihubungi. Formulir list penelusuran diberikan ke PJ HIV dan/atau RR di hari yang sama atau maksimal 7 hari setelah list penelusuran diberikan oleh layanan. (Lampiran 4) b) Petugas penelusur dan tim layanan HIV memberikan kode hasil penelusuran pasien dan menentukan rencana tindak lanjutnya. Petugas RR juga mencatat kode hasil penelusuran tersebut di belakang nomor rekam medis pasien.			
Kode Hasil Penelusuran	Hasil Penelusuran	Tindak Lanjut Penelusuran	Dicatat oleh
Tidak berhasil dihubungi dan tidak ditemukan			
#A01	ODHIV telah ditelusuri namun belum berhasil dihubungi/tidak berhasil bertatap muka namun masih berpotensi ditemukan sehingga direncanakan penelusuran ulang.	ODHIV ini akan masuk ke daftar ODHIV hilang di bulan berikutnya untuk dilakukan penelusuran lanjutan dan bila hasilnya belum ditemukan, maka ODHIV tidak perlu ditelusuri kembali dan hasil akhir penelusuran menjadi A0.	Petugas Penelusur & Petugas RR
#A0	ODHIV telah ditelusuri namun tidak berhasil ditemukan karena nomor tidak aktif atau alamat tidak sesuai.	Petugas penelusur menyertakan bukti pesan teks, daftar panggilan dan/atau foto lokasi penelusuran saat kunjungan rumah. Dalam kondisi ini, penelusuran tidak akan dilanjutkan.	Petugas penelusur & Petugas RR
	ODHIV tidak memiliki nomor kontak dan berdomisili di luar jangkauan petugas penelusur dan terkonfirmasi tidak mampu ditelusuri .	Petugas RR mencatat hasil A0 untuk ODHIV terkonfirmasi tidak mampu ditelusuri dengan mencatat tanggal penelusuran = tanggal pertemuan koordinasi	Petugas RR
Berhasil dihubungi			
#A1	ODHIV berhasil dihubungi atau ditemui namun ODHIV belum bersedia kembali untuk memulai atau melanjutkan pengobatan ARV	- Petugas penelusur/ tim layanan HIV menggali terkait tantangan dan alasan ODHIV tidak melanjutkan pengobatan di layanan HIV. - Petugas penelusur menekankan manfaat pengobatan ARV dan menawarkan kepada ODHIV untuk konsultasi melalui panggilan bersama dokter layanan PDP dan meninggalkan informasi kontak layanan PDP atau kontak petugas penelusur. - Dilakukan kembali maksimal dua kali siklus paket penelusuran dalam rentang waktu tiga sampai enam bulan. Bila ODHIV masih belum bersedia, ODHIV diarahkan untuk menandatangani surat pernyataan belum bersedia melanjutkan pengobatan ARV (sesuai format masing-masing layanan). - Petugas penelusur dapat diganti atas pertimbangan	Tim layanan HIV dan petugas penelusur

			fasyankes. 5. Apabila terdapat ancaman terhadap ODHIV dan/atau penelusur, penelusuran dihentikan. 6. Jika sudah ditelusuri dan hasil penelusuran tetap A1, ODHIV tersebut tidak menjadi prioritas untuk ditelusuri pada tahun berjalan .	
	#A2	ODHIV berhasil dihubungi atau ditemui dan bersedia memulai atau melanjutkan pengobatan ARV	1. Petugas penelusur/ tim layanan HIV menggali terkait tantangan dan alasan ODHIV tidak retensi terhadap pengobatan di layanan HIV. 2. Petugas penelusur mendorong ODHIV kembali akses dalam rentang waktu seminggu dan berkoordinasi dengan petugas layanan terkait penjadwalan pasien tersebut. 3. Apabila dalam 2 kali penjadwalan ODHIV tidak hadir, maka akan dilakukan kontak kembali 3 bulan sejak penjadwalan terakhir. 4. Bila ODHIV sudah bersedia dan kembali ke layanan maka diberikan kode hasil penelusuran T1.	Tim layanan HIV dan petugas penelusur
	#T1	ODHIV kembali ke layanan HIV dan/atau mendapatkan pengobatan ARV	1. Petugas layanan HIV melakukan evaluasi kembali pada ODHIV sesuai dengan paket positif SOP Tatalaksana HIV. 2. Petugas RR memperbarui status ODHIV di SIHA.	Tim layanan HIV dan petugas penelusur
	#M1	ODHIV diketahui meninggal	1. Petugas penelusur meminta salinan/foto surat kematian atau surat keterangan dari keluarga atau RT setempat atau bukti lain yang dapat dipercaya.	Tim layanan HIV dan petugas penelusur
	#RK1	ODHIV berhasil dihubungi atau ditemui dan bersedia memulai atau melanjutkan pengobatan ARV tetapi memilih rujuk keluar atau sudah terdaftar di layanan PDP lainnya.	Petugas penelusur melaporkan kepada layanan PDP: • ODHIV memilih rujuk keluar 1. Petugas penelusur menjelaskan prosedur rujuk keluar kepada ODHIV dan merekomendasikan ODHIV untuk kembali ke layanan PDP asal. 2. Petugas penelusur berkoordinasi dengan petugas layanan PDP untuk proses administrasi rujuk keluar. 3. Petugas layanan PDP melakukan proses rujuk keluar pada SIHA dengan menambahkan kunjungan baru. • ODHIV sudah terdaftar di layanan PDP lainnya 1. Petugas PDP melakukan konfirmasi ke layanan tersebut dan bila terkonfirmasi benar, petugas PDP membuat dan mengirimkan: a. Formulir rujuk keluar b. Ikhtisar perawatan pasien HIV dan ART yang terisi lengkap melalui email atau Whatsapp.	Tim layanan HIV dan petugas penelusur

		2. Petugas RR memperbarui status pasien tersebut pada menu "Data Pasien" di SIHA 2.1 menjadi Rujuk Keluar.	
	c) Petugas RR mencatat hasil penelusuran di SIHA 2.1 pada hari yang sama atau maksimal 7 hari dan sebelum tutup periode laporan setelah hasil penelusuran diterima dari tim penelusur. d) ODHIV tidak aktif adalah ODHIV hilang tidak lagi ditelusuri dan pada siklus akhir kegiatan penelusuran tidak dihitung dalam grafik perkembangan menuju 95-95-95. ODHIV dinyatakan tidak aktif apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: 1. ODHIV tidak aktif dari hasil penyisiran yaitu ODHIV tanpa nomor telepon dan alamat lengkap (tidak potensial ditelusuri) 2. ODHIV tidak aktif hasil penelusuran yaitu: a. ODHIV hilang durasi 2-24 bulan (≤ 2) Bila hasil akhir penelusuran adalah A0 ditunggu sampai 24 bulan (2 tahun) sejak jadwal kunjungan terakhir dan tidak berhasil kembali ke lapangan. b. ODHIV hilang durasi 25-60 bulan ($> 2-5$ tahun) Bila hasil akhir penelusuran adalah A0 ditunggu sampai 1 tahun setelah hasil penelusuran A0. c. ODHIV hilang durasi lebih dari 60 bulan (> 5 tahun) Langsung ditetapkan apabila hasil penelusuran A0. e) Jika ditemukan ODHIV tidak aktif maka petugas RR akan: 1. Mengeluarkan data ODHIV tersebut dari daftar ODHIV hilang. 2. Mengeluarkan data ODHIV tersebut dari kaskade bar 95 pertama. 3. Memasukkan kembali data ODHIV tersebut ke dalam perhitungan kaskade apabila ODHIV tersebut sudah kembali akses layanan PDP. e. Pemutakhiran Data ODHIV Hilang a) Pemutakhiran data tingkat fasyankes dilakukan setiap bulan. b) Pada akhir siklus kegiatan penelusuran, Petugas RR melakukan pemutakhiran grafik kaskade perkembangan 95-95-95 menggunakan Tools Analisis SIHA.		

Diagram/Bagan alir	Persiapan verifikasi data pasien dan data kunjungan Penarikan data ODHIV hilang di SIHA Potensial ditelusuri Pertemuan koordinasi awal/rutin Kegiatan penelusuran pasien hilang oleh petugas penelusur Hasil akhir dan tindak lanjut hasil penelusuran (pencatatan) Ditemukan Tidak ditemukan Tidak potensial ditelusuri Melengkapi data individu dan verifikasi menggunakan sumber data lain Tersedia informasi kontak? Ya Tidak Status ODHIV tidak aktif Pemutakhiran data
Unit Terkait	1. Layanan internal yang terintegrasi dengan penelusuran ODHIV 2. Komunitas/LSM Lokal/Kader/ orang atau pihak yang ditunjuk atau disepakati untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran ODHIV 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota